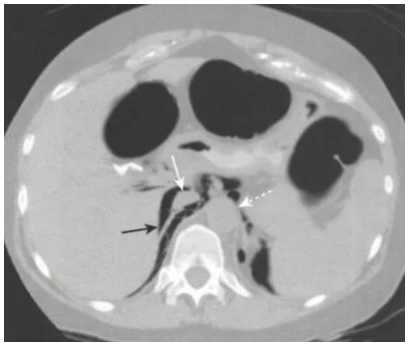
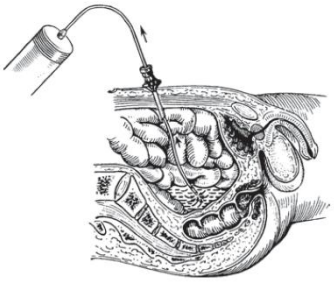
胰腺	多有	晚而重	多见于方向盘/车把伤（概率仅 1-2%）胰腺横在脊柱前方,暴力把胰腺压到脊柱上压坏 疼痛局限在腰背部或上腹偏左 腹穿淀粉酶明显(×轻度)高，可有假性囊肿（左上腹包块）不能看到淀粉酶高就直接得出胰腺损伤,因为消化道内也有淀粉酶 注意：假性囊肿多继发于胰腺炎，少数继发于胰腺外伤、胰腺癌
结肠	多无	晚而重(太干)	黑便，可有肝浊音界缩小消失 治疗： ①少数污染轻（多为右半结肠损伤）：一期肠修补或切除吻合 ②大多污染重（多为左半结肠损伤）：造口或外置、3-4 周后处理
直肠	直肠上段损伤：表现类似结肠损伤 治疗：肠修补或切除吻合+乙状结肠双腔造口		
	直肠下段损伤：直肠周围感染、无腹膜炎 治疗：乙状结肠双腔造口不发生腹膜炎,只需要解决粪便问题即可		

直肠上段与直肠下段的血供不同,左半边的结肠与直肠上段血供也不同,左半边的结肠的血供来自于肠系膜下动脉,血供很单一,肠壁的血供非常差,愈合不良,因此左半结肠损伤不做修补吻合。
而直肠上段的血供来自于直肠上动脉,直肠上动脉在盆腔内形成丰富的血管网,血供明显优于左半结肠,所以直肠上段损伤是可以直接去修补的,但是得做造口





四、检查

1.腹腔穿刺（90%阳性率→首选、金标准）

①抽出不凝血→脾、肝（含胆汁）、胰（含淀粉酶）等

（腹膜去纤维-不凝血；出血太多有时也能看到血凝块-超过腹膜去纤维）

②抽出消化液　不能因为出现了血凝块否定腹腔出血

③结肠损伤行腹腔灌洗：含大量细菌的消化液

④腹腔穿刺的禁忌症：严重腹胀(麻痹性肠梗阻非常严重)、ttsx 中晚期妊娠、躁动不能合作者、明显粘连(既往粘连)（夫人早恋）

注意：外科腹部损伤章节有腹穿选腹穿；对比消化性溃疡穿孔首选 X 线（膈下新月形游离气体）、也可腹腔穿刺(好发于胃窦、小弯、十二指肠球部(不是腹膜后))

2.影像学 肾损伤需要分型(单纯裂伤、部分裂伤、全层裂伤),不同分型治疗原则不同,而B超无法对肾损伤进行分型

①B 超和 CT：脾、肝、胰损伤首选 B 超（否则 CT）；肾损伤首选 CT 注意有腹穿选腹穿

②X 线（腹部脏器损伤诊断已确定或伴休克者不必再进行 X 线）

可有膈下新月形游离气体	胃前壁、十二指肠 1 部、结肠、空回肠损伤（相对少见）本身气体不多,积在肝周围的气体也不多 体征:肝浊音界缩小消失
可有腹膜后积气	胃后壁、十二指肠 2/3 部损伤

不推荐磁共振用于急诊,因为太慢

五、剖腹探查

①全身情况有恶化趋势→抗休克同时剖腹探查紧急手术（正中切口）肝脾损伤更常见,便于探查

对比：腹腔感染章节的继发性腹膜炎-右旁正中切口